

doi: 10.3978/j.issn.2095-6959.2016.06.014

View this article at: <http://dx.doi.org/10.3978/j.issn.2095-6959.2016.06.014>

# 新型健康管理模式在老年综合评估中的应用研究

孔亚婷, 朱正庭

(宜昌市中心医院神经科, 湖北 宜昌 420500)

**[摘要]** **目的:** 分析老年综合评估在构建老年新型健康管理模式中的应用价值。**方法:** 将2014年至2015年社区老年中心、养老院、宜昌市中心医院老年病科、综合内科的300例老年患者平均分为研究组和对照组, 对对照组患者实施常规健康管理, 对研究组患者进行老年综合评估, 并根据评估结果制定新型健康管理模式对患者实施健康管理。**结果:** 实施健康管理前两组患者的生活质量综合评定问卷(Generic Quality of Life Inventory-74, GQOLI-74)评分、日常生活能力量表(Activity of Daily Living Scale, ADL)评分比较均无显著性差异( $P>0.05$ ), 实施健康管理后研究组患者的GQOLI-74问卷评分、ADL量表评分均较对照组患者高( $P<0.05$ ), 其家属对健康管理工作的满意度为91.3%, 与对照组患者家属的83.3%比较存在明显差异( $P<0.05$ )。**结论:** 以老年综合评估为核心, 构建老年新型健康管理模式对老年人实施健康管理, 可有效改善老年人的生活质量。

**[关键词]** 老年人; 老年综合评估; 新型健康管理模式; 生活质量

## Application of new health management in elderly comprehensive assessment

KONG Yating, ZHU Zhengting

(Department of Neurology, Yichang Central Hospital, Yichang Hubei 420500, China)

**Abstract** **Objective:** To analyze the application value of elderly comprehensive assessment in the construction of new health management for elderly. **Methods:** 300 cases of elderly patients from 2014 to 2015 in the Community Senior Centers, Nursing Homes, and Geriatrics of Integrated Medicine of Yichang Central Hospital were selected and divided into the research group and control group on average. The control group was given conventional health management, and the research group was given elderly comprehensive assessment, and according to the assessment results, we formulate the new health management mode for patients. **Results:** There were no significant differences between GQOLI-74 questionnaire (comprehensive assessment of the quality of life questionnaire) scores, Activity of Daily Living Scale (ADL) scores of these two groups before the health management ( $P<0.05$ ), and after the health management, the GQOLI-74 questionnaire score, ADL scale score in the research group were significantly higher than in the control group ( $P<0.05$ ), and there was significant difference between the family satisfaction on health management (91.3%) in the research group and (83.3%) in the control group ( $P<0.05$ ). **Conclusion:** As the core of elderly comprehensive assessment, constructing the new health management for elderly can effectively improve the life quality for elderly.

**Keywords** elderly; elderly comprehensive assessment; new health management; life quality

收稿日期 (Date of reception): 2016-01-13

通信作者 (Corresponding author): 孔亚婷, Email: kongyatings@sina.com

伴随着人口老龄化进程的不断加快,我国老年慢性疾病患者的发病率呈现出不断增长的趋势,面对老年患者对健康的需求,新形势下我国构建老年新型健康管理模式已迫在眉睫。早期,我国临床多通过传统的健康评估方法对老年患者的健康状况进行评估,为患者制定健康管理模式,但该种健康评估方法以主观判断为主,缺乏量化指标。近年来,国外一些发达国家推行老年综合评估,获得了良好的应用效果<sup>[1-6]</sup>。基于上述现状,本次研究对老年综合评估在构建老年新型健康管理模式中的应用价值进行了探讨,旨在能够明确老年患者最佳的治疗或个案管理方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究以三峡大学第一临床医学院老年医学科为依托,随机性纳入2014年至2015年社区老年中心、养老院和宜昌市中心医院老年病科、综合内科的300例老年患者作为研究对象。300例老年患者均无认知功能障碍。采用随机数字表法将300例老年患者平均分成研究组和对照组。使用统计学软件对两组研究对象的一般资料进行统计学处理发现,两组间存在的差异无统计学意义( $P>0.05$ )(见表1)。本次研究开展前已事先获取患者及其家属的知情同意,患者家属同意患者参与本次研究,并已在具有法律效力的临床研究知情同意书上签字。

1.2 研究方法

本次研究对对照组患者实施常规健康管理,对研究组患者进行老年综合评估,并根据评估结果制定新型健康管理模式对患者实施健康管理。

新型健康管理模式的制定方法总结如下:  
1)社区老年中心、养老院和宜昌市中心医院老年

病科、综合内科的患者均组建老年健康管理小组,该小组具有健康体检、健康管理和医疗功能。2)评估方法:采用的评估方法主要包括两种,一种是通过综合测量工具的直接测量获取评估结果,另一种是通过单项测量工具的各个维度进行评价,综合分析各维度评价结果得出最终评估结果。3)由小组成员根据老年综合评估结果制定老年人健康管理规划,为老年人提供健康管理服务。老年综合评估维度包括排除慢性疾病急性加重期的老年患者的躯体健康、生活能力、精神健康、社会健康、经济和环境情况,评估对象为,根据老年综合评估结果制定新型的健康管理模式,该模式中包括具有针对性的疾病预防、保健、治疗、康复和护理计划。

1.3 评价指标

本次研究对比两组患者实施健康管理前、实施健康管理后的生活质量、日常生活能力以及两组患者家属对健康管理工作的满意度。

1.4 评价标准

生活质量:使用GQOLI-74问卷评价两组患者的生活质量,该问卷中共包括74个评价项目,划分为躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态四个评价维度,对应的条目分别为11~30条、31~50条、51~70条、1~10条,评分上限为100分,评分高低与患者生活质量成正比。

日常生活能力:使用ADL量表评价两组患者的日常生活能力,问卷中共包括20个评价条目,包括躯体生活自理和工具性日常生活能力,评分上限为100分,评分高低与患者日常生活能力成正比。

家属满意度:两组患者家属对健康管理工作的满意度通过问卷调查获得,问卷中包括十分满意、满意和不满意三个选项,满意度=十分满意(%) + 满意(%)。

表1 两组研究对象的一般资料比较[n (%)]  
Table 1 Comparison of the general data of the two groups of subjects [n (%)]

| 组别           | 例数  | 男/女   | 年龄/岁       | 首发基础疾病病程/年 |
|--------------|-----|-------|------------|------------|
| 研究组          | 150 | 71/79 | 75.6 ± 2.1 | 10.9 ± 1.1 |
| 对照组          | 150 | 69/81 | 76.1 ± 1.9 | 10.5 ± 1.3 |
| $\chi^2/t$ 值 | -   | 0.054 | 0.790      | 1.050      |
| P值           | -   | 0.817 | 0.435      | 0.300      |

1.5 统计学处理

研究过程中涉及到的符合正态分布的研究数据均进行统计学处理, 统计学软件版本为SPSS19.0, ADL量表评分、GQOLI-74问卷评分等量性指标均采用( $\bar{x} \pm s$ )表示, 性别比例、患者家属满意度等计数指标均采用[n (%)]表示, 组间指标差异分别采用(t)和( $\chi^2$ )检验,  $P < 0.05$ 表示两者比较存在的差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的生活质量比较

实施健康管理前两组患者的GQOLI-74问卷评分比较无明显差异( $P > 0.05$ ), 实施健康管理后研究组患者的GQOLI-74问卷评分明显高于对照组患者

( $P < 0.05$ ), 具体研究数据见表2。

2.2 两组患者的日常生活能力比较

实施健康管理前两组患者的ADL量表评分比较无显著性差异( $P > 0.05$ ), 实施健康管理后研究组患者的ADL量表评分明显高于对照组患者( $P < 0.05$ ), 研究数据统计学处理结果见表3所示。

2.3 两组患者家属对健康管理工作的满意度比较

本次研究共为两组患者家属发放300份满意度调查问卷, 有效回收率为100.0%。统计问卷结果得出研究组患者家属对健康管理工作的满意度为91.3%, 与对照组患者家属的83.3%比较存在明显差异( $P < 0.05$ ), 具体研究数据见表4。

表2 两组患者实施健康管理前后的GQOLI-74问卷评分比较( $\bar{x} \pm s$ )

Table 2 Comparison of GQOLI-74 questionnaire scores between two groups before and after the implementation of health management ( $\bar{x} \pm s$ )

| 组别         | 健康管理前      | 健康管理后      |
|------------|------------|------------|
| 研究组(n=150) | 56.5 ± 4.1 | 76.9 ± 3.5 |
| 对照组(n=150) | 57.1 ± 4.3 | 65.8 ± 4.1 |
| t值         | 0.452      | 9.209      |
| P值         | 0.654      | 0.000      |

表3 两组患者实施健康管理前后的ADL量表评分比较( $\bar{x} \pm s$ )

Table 3 Comparison of ADL scale scores between two groups before and after the implementation of health management ( $\bar{x} \pm s$ )

| 组别         | 健康管理前      | 健康管理后      |
|------------|------------|------------|
| 研究组(n=150) | 49.8 ± 4.9 | 71.5 ± 4.2 |
| 对照组(n=150) | 50.1 ± 4.8 | 60.5 ± 4.6 |
| t值         | 0.196      | 7.898      |
| P值         | 0.846      | 0.000      |

表4 两组患者家属对健康管理工作的满意度比较[n (%)]

Table 4 Comparison of the family members' satisfaction with health management in the two groups [n (%)]

| 组别  | 例数  | 十分满意 | 满意 | 不满意 | 满意度  |
|-----|-----|------|----|-----|------|
| 研究组 | 150 | 96   | 41 | 13  | 91.3 |
| 对照组 | 150 | 86   | 39 | 25  | 83.3 |

组间比较,  $\chi^2=4.339$ ;  $P=0.037$ 。

Comparison between groups,  $\chi^2=4.339$ ;  $P=0.037$ .

### 3 讨论

1)老年综合评估的本质和应用目的。老年综合评估在上个世纪40年代被英国学者<sup>[7]</sup>提出,最初被应用于评估虚弱老年人的机体状况,指导该类患者的临床治疗,以促使患者早日恢复健康。现阶段,我国临床医疗领域将老年综合评估定义为一种包括多维度、跨学科的诊断过程,通过这一诊断过程确定老年人群在心理学、社会学、医学、功能状态等方面所具有的功能和存在的问题,指导临床为老年人群制定优质的健康管理方案,来提高老年人群的生活质量<sup>[8-9]</sup>。该种诊断过程的具体应用目的可以总结为以下几点:①在早期明确老年人群存在的潜在的功能缺陷;②在早期明确老年人群对健康管理的需求;③为临床治疗老年健康管理模式提供指导价值;④通过追踪、随访评估老年人群的健康管理效果,对健康管理模式的应用价值进行科学性的评价<sup>[2,10]</sup>。

老年综合评估与传统的老年人健康体检不同,老年综合评估是指对老年人群进行疾病、体能、认知、心理和社会等多个层面的评估,而这些层面的问题均有一个共同的特点,即均是与老年人群健康存在相关性的问题。老年综合评估的主要评估内容包括:①老年人群整体疾病的诊疗评估,评估这一内容需要采集老年患者的完整病史,从单一器官的诊疗到整体、规范化的处理;②老年患者常见临床症状评估,筛查老年患者常见临床症状,分析临床症状与老年患者机体健康状况之间存在的相关性;③躯体功能评估,包括日常生活能力,具体划分为个人卫生处理、上厕所、行走、上下楼梯等;④认知功能,评估导致老年患者出现认知功能障碍的危险因素,如既往有脑部疾病史、精神障碍性疾病史等;⑤心理状态评估,老年患者多合并患有多种慢性疾病,兴趣爱好减少,躯体活动功能受限,较易产生不良情绪,故心理状态评估主要评估老年患者有哪些不良情绪以及老年患者产生不良情绪的具体原因,注重老年患者的心理疏导。

2)老年综合评估在老年患者健康管理中的具体应用。①躯体健康、生活能力:老年综合评估中躯体健康的评估内容包括日常生活能力、机体营养状况、感觉功能、用药情况等评估,常用评估工具为一般问卷。生活能力评估包括日常平衡与步态、穿衣、洗漱、上下楼梯、独立处理财务、操持家务、使用公共交通工具等,常用工具为日常生活能力量表(ADL)和生理性日常生活能力

量表(Physical Activities of Daily Living, PADL)。

②精神健康:老年综合评估中精神健康的评估包括老年患者的心理状态(焦虑、抑郁、紧张等)、认知功能,常用的评估工具为简易精神状态量表(Minimum Mental State Examination, MMSE)、焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale, SAS)、抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale, SDS)。

③社会健康:老年综合评估中社会健康的具体评估内容主要为社会支持需求和获得,常用的评估工具为社会支持评定量表(Social Support Rating Scale, SSRS)和领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale, PSSS)。

④经济和环境情况:老年综合评估中经济和环境情况的评估内容包括经济状况、医疗资源获得情况、交通、通讯、家庭的安全性等,评估工具为一般问卷。

3)结果分析。经研究发现研究组患者实施健康护理后的生活质量和日常生活能力明显优于对照组患者,其家属对健康管理工作的满意度也较对照组患者家属高。本次研究所得结果与屈海宏等<sup>[11]</sup>在对“老年综合评估护理干预在提高老年冠心病患者生活质量中的应用”这一课题进行研究时所得研究结果具有高度相似性。综合分析本次研究结果得出以老年综合评估为核心,构建老年新型健康管理模式对老年患者实施健康管理,可有效提高老年患者的生活自理能力和生活质量,有利于医务人员对老年患者进行循证、科学的健康管理,同时也有利于患者自觉参与自身的健康管理。总之,老年综合评估在构建老年新型健康管理模式中的应用,能够最大程度的体现生物-心理-社会医学的本质,具有十分显著的推广应用价值。

### 参考文献

1. Larsen MD, Rosholm JU, Hallas J. The influence of comprehensive geriatric assessment on drug therapy in elderly patients[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2014, 70(2): 233-239.
2. Kim KI, Park KH, Koo KH, et al. Comprehensive geriatric assessment can predict postoperative morbidity and mortality in elderly patients undergoing elective surgery[J]. Arch Gerontol Geriatr, 2013, 56(3): 507-512.
3. Griebbling TL. Re: comprehensive geriatric assessment can predict postoperative morbidity and mortality in elderly patients undergoing

- elective surgery[J]. J Urol, 2014, 191(2): 386-387.
4. Teymoortash A, Halmos GB, Silver CE, et al. On the need for comprehensive assessment of impact of comorbidity in elderly patients with head and neck cancer[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014, 271(10): 2597-2600.
  5. Ungar A, Schoenberger A, Maggi S, et al. The value of comprehensive geriatric assessment in elderly patients with severe aortic stenosis—a position statement of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)[J]. European Geriatric Medicine, 2015, 6(3): 271-273.
  6. Račić M, Petković N, Bogičević K, et al. Comprehensive geriatric assessment: comparison of elderly hemodialysis patients and primary care patients[J]. Ren Fail, 2015, 37(7): 1126-1131.
  7. Ruiz M, Reske T, Cefalu C, et al. Management of elderly and frail elderly cancer patients: the importance of comprehensive geriatrics assessment and the need for guidelines[J]. Am J Med Sci, 2013, 346(1): 66-69.
  8. Merli F, Luminari S, Rossi G, et al. Outcome of frail elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma prospectively identified by Comprehensive Geriatric Assessment: results from a study of the Fondazione Italiana Linfomi[J]. Leuk Lymphoma, 2014, 55(1): 38-43.
  9. Pottel L, Lycke M, Boterberg T, et al. Serial comprehensive geriatric assessment in elderly head and neck cancer patients undergoing curative radiotherapy identifies evolution of multidimensional health problems and is indicative of quality of life[J]. Eur J Cancer Care (Engl), 2014, 23(3): 401-412.
  10. Kuo MC, Jeng C, Chen CM, et al. Profile of elderly with multiple physician visits: advocacy for tailored comprehensive geriatric assessment use in clinics[J]. Geriatr Gerontol Int, 2014, 14(2): 372-380.
  11. 屈海宏, 陈长香, 徐爱茹, 等. 老年综合评估护理干预在提高老年冠心病患者生活质量中的应用[J]. 中华现代护理杂志, 2014, 20(20): 2485-2488.
- QU Haihong, CHEN Changxiang, XU Airu et al. Application of comprehensive geriatric assessment nursing model on the quality of life in elderly patients with coronary heart disease[J]. Chinese Journal of Modern Nursing, 2014, 20(20): 2485-2488.

本文引用: 孔亚婷, 朱正庭. 新型健康管理模式在老年综合评估中的应用研究[J]. 临床与病理杂志, 2016, 36(6): 788-792. doi: 10.3978/j.issn.2095-6959.2016.06.014

**Cite this article as:** KONG Yating, ZHU Zhengting. Application of new health management in elderly comprehensive assessment[J]. Journal of Clinical and Pathological Research, 2016, 36(6): 788-792. doi: 10.3978/j.issn.2095-6959.2016.06.014